

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Azithromycin 15mg/g (아지터점안액, 삼일제약(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1g 중 azithromycin 15mg

☐ 효능 효과 :

1. 유효균종

헤모필루스 인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스, 클라미디아트라코마티스, 폐렴미코플라즈마, 연쇄구균, 포도구균, 스트렙토코쿠스 피오게네스, 스트렙토코쿠스 비리단스, 임균

2. 적응증

감수성 세균에 의한 만 2세 이상 소아 및 성인의 화농성 세균성 결막염

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2010년 제2차 약제급여평가위원회 : 2010년 2월 25일

2010년 제6차 약제급여평가위원회 : 2010년 6월 24일(재평가)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2010년 제2차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “감수성 세균에 의한 만 2세 이상 소아 및 성인의 화농성 세균성 결막염”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 비열등하였고 투약일수가 짧은 장점이 있으나, 투약비용이 대체약제의 포장단위당 가중소요비용보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사(0.25ml×6병)가 대체약제의 가중평균가(■) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

□ 최종결과

○ 비급여

※ 2010년 제 6차 약제급여평가위원회 평가결과: 기심의결과유지(조건부 비급여)

- 신청품은 “감수성 세균에 의한 만 2세 이상 소아 및 성인의 화농성 세균성 결막염”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 비열등하였고 투약일수가 짧은 장점이 있으나, 투약비용이 대체약제의 포장단위당 가중소요비용보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 ■ 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “감수성 세균에 의한 만 2세 이상 소아 및 성인의 화농성 세균성 결막염”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 ofloxacin, tobramycin, levofloxacin 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 nitrogen을 함유한 macrolide(azalide)계 항균제이며, 세균성 결막염 치료제로 교과서에 소개되고 있으며¹⁾, 가이드라인에 제시되어 있지 않음.
- 화농성 세균성 결막염으로 진단된 환자 1,015명을 대상으로 단일맹검 임상시험을 수행하여 9일째 임상적 치료효과를(PP분석) 평가한 결과 1.5% azithromycin 3일 투여군은 0.3% tobramycin 7일 투여군과 치유²⁾된 환자비율이 비열등하였음(87.8% vs 89.4%,

difference:-1.6%, 95% CI:-7.5%,4.4%, noninferity margin: 10%).³⁾⁴⁾

- 이차 임상효과 비교에서 3일째 cure rate은 azithromycin이 tobramycin에 비해 높았으나, 1차 효과변수인 9일째의 임상적 치료효과는 비열등하였고, Bacteriological resolution은 3일째와 9일째 모두 비열등함을 고려시 신청품의 임상적 개선 여부가 불분명함.
- 사망 또는 중대한 이상반응은 보고되지 않았으며, 약제관련 이상반응은 azithromycin군 3명(작열감 2명, 작열감과 이물감 1명), tobramycin군 1명(삼출액)에 나타났고, 이중 azithromycin 군 2명은 시험을 중단함.
- 활동기 trachoma로 진단된 환자 670명의 기니와 파키스탄 1-10세 어린이를 대상으로 이중맹검, 무작위, double-dummy 임상시험을 수행하여 60일째 임상적 치료효과를(PP 분석) 평가한 결과 1.5% azithromycin 3일 투여군은 azithromycin 시럽제 단회투여군과 치유⁵⁾된 환자비율은 비열등하였음(96.3% vs 96.6%, difference: -3.3%, 95% CI: -4.6%,3.9%, noninferity margin: -10%).⁶⁾
 - 치료와 관계된 이상반응은 없었으나, 안구이상반응은 점안액군 8.9%, 시럽제군 13.1%, 전신이상반응은 10.2%, 시럽제군 9%였고, 가장 많이 발생된 안구 이상반응은 알러지성 결막염이었음.
 - 트라코마는 클라미디아트라코마티스로 인한 만성결막염으로 위생환경이 좋지 않은 저개발국가에서 볼 수 있는 전염질환으로, 우리나라는 1950년 이후 감염이 보고되지 않고있음.⁷⁾
- 동일성분의 1% 점안제와 농도, 포장단위, 용법용량 및 효능효과에 차이가 있는 점을 고려 시 두 약간의 비교를 하기 어렵지만, 급성세균성결막염에서는 임상적으로 큰 차이가 있지는 않을 것으로 생각되고, 이와 같은 농도 차이에 따라 환자군 범위에 차이가 있지는 않을 것임.⁸⁾

○ 비용 효과성

- 세균성 결막염에 사용되는 약제 10개 성분⁹⁾ 중 상위 3품목이 전체 청구량의 약 ■■■를 차지하는 점을 고려하여, ofloxacin, tobramycin, levofloxacin을 신청품의 대체 약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 비열등하고, 해당 적응증이 급성질환임을 고려하여 포장단위당 가중 소요비용을 비교시, 신청품의 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제 가중평균가¹⁰⁾인 ■■■원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■임.

○ 재정 영향¹¹⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ofloxacin, tobramycin, levofloxacin 대체로 인한 재정소요금액¹³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.
- 대체가능약제 중 소량 청구품목으로 대체약제에 포함되지 않은 품목을 감안시 실제 재정증감액에 변동이 있을 수 있음.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ofloxacin, tobramycin, levofloxacin의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일에 등재되어있음.

Reference

- 1) Mandell et al, principles and practice of infectious diseases, 7th
- 2) cure(치유)= 안구충혈과 삼출액이 없는 상황
- 3) Cochereau et al, 3-day treatment with azithromycin 1.5% eye drops versus 7-day treatment with tobramycin 0.3% for purulent bacterial conjunctivitis: multicentre, randomised and controlled trial in adults and children. Br J Ophthalmol 2007 91: 465-469
- 4) Denis et al, Microbiologic efficacy of 3-day treatment with azithromycin 1.5% eyedrops for purulent bacterial conjunctivitis. Eur J Ophthalmol 2008;18:858-868
- 5) cure(치유)= 시험 마지막날(LOCF) 안좋은 눈의 상태가 TF0(<5 follicles with at least 0.5mm diameter in the upper tarsal conjunctiva)
- 6) Cochereau et al, Efficacy and safety of short duration azithromycin eye drops versus azithromycin single oral dose for the treatment of trachoma in children: a randomised, controlled, double-masked clinical trial. Br J Ophthalmol 2007 91: 667-672
- 7) 안과학, 제8판, 이진학 등, 일조각
- 8) 대한안과학회■■■
- 9) 0.3% ofloxacin, 0.3% tobramycin, 0.5% levofloxacin, 0.3% gentamicin sulfate, 0.5% moxifloxacin HCl, 0.3% gatifloxacin, 0.1% fusidic acid, 0.3% norfloxacin, 0.3% ciprofloxacin, 0.3% micronomicin sulfate
- 10) 09년 가중평균가 및 ■■■에서 연간 청구자료(건강보험 EDI 청구심사분, 보건기관, 약국 청구분 제외)를 사용하여 대체약제 가중평균가 산출함.
- 11) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

12) 제약사제시 예상사용량×신청약가

13) 재정증감액=(신청약가 - 대체약제 가중평균가)×제약사 제시 예상사용량

14) 제약사제시 예상사용량×대체약제 가중평균가